DỊCH TỄ HỌC VÀ DỰ PHÒNG CÁC BỆNH TIM MẠCH

TS Nguyễn trần Hiển

1. Đặt vấn đề

Từ xưa cho đến thời gian gần đây, mô hình bệnh tật ở nước ta là điển hình của một nước nghèo, kém phát triển, có đời sống chưa cao, trình độ vệ sinh thấp, lại ở vào một vùng nhiệt đới với một khí hậu nóng bức ẩm ướt, nên các bệnh tật chủ yếu là những bệnh truyền nhiễm (nhiễm trùng, siêu vi trùng, ký sinh trùng) và các bệnh suy dinh dưỡng.

Hiện nay mô hình này tuy đã được cải thiện đáng kể, nhưng cơ bản vẫn còn tồn tại. Trong khi đó thì lại đã bắt đầu hình thành một mô hình bệnh tật của các nước phát triển, với sự xuất hiện ngày càng nhiều những bệnh tim mạch, ung thư, thần kinh và tai nạn giao thông mà trước đây rất hiếm gặp.

Những bệnh Tim mạch có ý nghĩa quan trọng về y tế công cộng là:

- Đột quị
- Bệnh mạch vành
- Tăng huyết áp

1.1 Định nghĩa Bệnh mạch vành

Những triệu chứng này được biểu hiện theo 3 cách:

- Một cơn đau thắt ngực khi gắng sức hay cơn đau thắt ngực ổn định
- Cơn đau thắt ngực không ổn định.
- Nhồi máu cơ tim.

1.1.1 Cơn đau thắt ngực khi gắng sức

Trong thể điển hình nhất của nó, bệnh nhân, thường là một người đàn ông vào lứa tuổi 50, khi gắng sức làm một việc gì đó, bỗng cảm thấy đau trong ngực như cả lồng ngực bị một cái gì đó bó chặt lại. Cơn đau có thể lan lên cổ, ra hai hàm răng, cánh tay trái, và thậm chí xuống đến hai cổ tay. Người bệnh vội ngưng sự gắng sức, và thường là vài phút sau, cơn đau biến mất.

Trong những thể không điển hình, cơn đau có thể khu trú ở những nơi khác như:

- Ở vùng thượng vị, ngang với vị trí bao tử, dễ nhầm lẫn với bệnh loét bao tử.
- Ở ngang các xương sườn, nhất là về phía trái
- Ở lưng, giữa hai xương bả vai, nhất là gần xương bả vai trái.
- Có khi không gây cảm giác co thắt, mà gây cảm giác như nóng bỏng trong ngực.

Những cơn đau này rất khó chịu, dài ngắn không chừng và thường có kèm theo một cảm giác lo sợ.

Khi có những triệu chứng này, không được coi thường, không được tự chẩn đoán bệnh, phải đi đến ngay một bác sĩ chuyên khoa về tim mạch để khám bệnh.

1.1.2 Cơn đau thắt ngực không ổn định

Bệnh đã vào một trạng thái đáng lo ngại hơn. Cơn đau nặng hơn, xuất hiện khi chỉ hơi gắng sức một chút, và có khi ngay cả trong lúc nghỉ ngơi, hoặc ngay trong giấc ngủ làm bệnh nhân phải tỉnh giấc. Bệnh nhân có thể có nhiều cơn trong một ngày, mỗi cơn kéo dài từ 10 đến 15 phút, rất thường hay xẩy ra ở phân nửa sau của đêm. Có thể xẩy ra ở những người từ trước đến giờ, chưa hề có những cơn đau như vậy. Đây thực sự là một đe doạ sẽ xẩy ra nhồi máu cơ tim.

Khi có những triệu chứng này, không được chậm trễ, phải đi đến ngay một bác sĩ chuyên khoa về tim mạch để khám bệnh. Nếu cơn đau kéo dài, phải nhập viện, vào một khoa tim mạch cấp cứu.

1.1.3 Nhồi máu cơ tim

Đó là biến chứng cực kỳ cấp tính xẩy ra bởi một vùng nào đó của cơ tim bỗng đột ngột không được máu tới tưới tắm, nên thiếu hẳn oxy và vì thế sẽ đi vào trạng thái hoại tử, bị phá huỷ. Thường bắt đầu rất đột ngột. Đau thắt vùng ngực, có thể lan lên cổ, ra hàm răng, cánh tay trái. Kèm theo là một cảm giác lo sợ tưởng sắp chết đến nơi. Mồ hôi vã ra như tắm. Mặt nhợt nhạt. Muốn ngất xỉu. Cơn đau có thể kéo dài vài giờ đến vài ngày. Cũng có thể dịu đi hay biến mất sau từ 15 phút đến một giờ. Thường xẩy ra ở những người đang có bệnh ở động mạch vành, nhưng cũng có thể đột ngột xẩy ra ở một người từ trước tới nay chưa hề có một triệu chứng nào ở tim. Có thể có những triệu chứng nhẹ hơn: cơn đau vẫn có, nhưng không nặng nề lắm, có thể chịu đựng được, chỉ kéo dài khoảng từ 15 đến 30 phút. Người bệnh mất cảnh giác, coi thường bệnh của mình.

Đôi khi, cơn đau xuất hiện, làm ngưng tim ngay, người bệnh có thể chết đột ngột. Khi có những triệu chứng này

- Phải gọi ngay đến trung tâm cấp cứu tim mạch.
- Phải uống ngay 2 viên Aspirine (1g) nếu trước đó không bị bệnh loét dạ dầy tá tràng.
- Phải ngậm ngay một hay hai viên thuốc giãn mạch Trinitrine hay Risordan.

Cần phải đưa ngay đến một đơn vị săn sóc đặc biệt ở một trung tâm chuyên khoa tim mạch càng nhanh càng tốt, không được để chậm trễ mất một phút nào.

1.2 Định nghĩa Tai biến mạch máu não

* Định nghĩa của TCYTTG: "*TBMMN là sự xẩy ra đột ngột các thiếu sót chức năng thần kinh, thường là khu trú hơn là lan toả, tồn tại quá 24 giờ hoặc gây tử vong trong 24 giờ. Các khám xét loại trừ nguyên nhân chấn thương*" (công bố 1990, bản tiếng Pháp)

Chẩn đoán bệnh theo tiêu chuẩn này chủ yếu là hỏi bệnh, TCYTTG đã thử nghiệm tại cộng đồng, nếu chỉ cần chẩn đoán có thật TBMMN thì sai số là 5%.

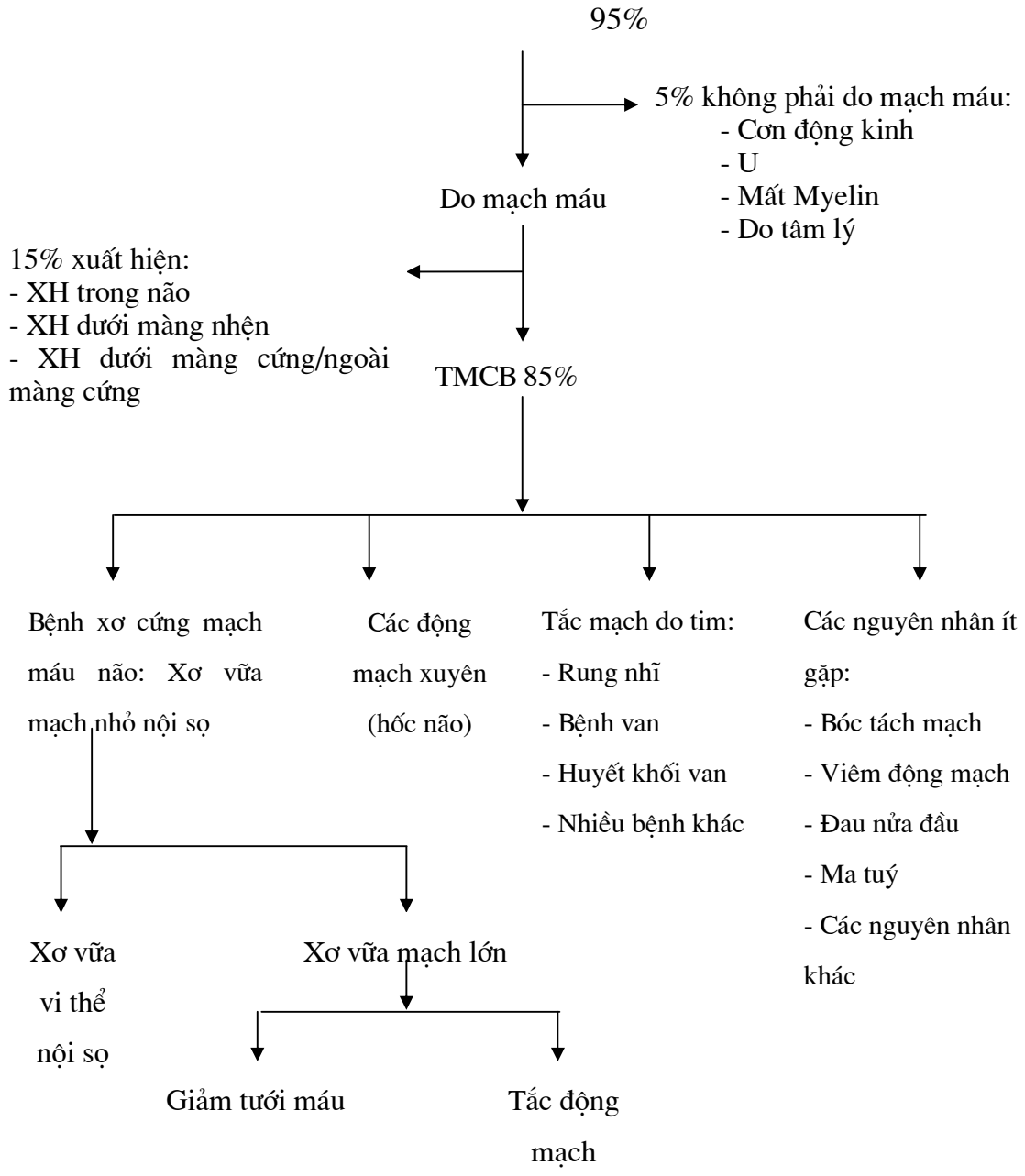
* *Sự tiến triển của bệnh theo thời gian* trong 2 - 3 tuần đầu để phân loại tai biến xuất huyết (TBXH) và thiếu máu cục bộ (TMCB), theo 5 loại như sau:

- Khỏi hoàn toàn trước 24 giờ: Thiếu máu cục bộ thoảng qua (TMCBTQ) (loại này coi là yếu tố nguy hiểm chứ không thực sự là TBMMN).

- Khỏi hoàn toàn quá 24 giờ: TBMMN một phần hồi phục, hoặc TMCBTQ kéo dài.
- Khỏi một phần với di chứng kéo dài.
- Không hồi phục và nặng lên liên tục.
- Chết

Loại thứ nhất và thứ hai thường là TMCB như tên gọi. Loại 4 và loại 5 có thể là xuất huyết (XH) hoặc TMCB nặng, cần xác định bằng cận lâm sàng.

Sơ đồ 1. SƠ ĐỒ CHẨN ĐOÁN TBMMN VÀ NGUYÊN NHÂN ĐỘT NGỘT XUẤT HIỆN TRIỆU CHỨNG THẦN KINH KHU TRÚ



1.3 Định nghĩa bệnh tăng huyết áp (THA)

Dưới đây trình bày định nghĩa THA của TCYTTG:

	Huyết áp tâm trương mmHg	Huyết áp tâm thu mmHg
Bình thường	< 90	< 140
Tăng HA giới hạn	90-95	140-160
Tăng HA thực sự	>95	>160

Người ta chia THA ra làm hai loại sau:

- Tăng huyếtt áp thứ phát: Là THA có các nguyên nhân xác định được như:
  - Các bệnh thận như viêm thận mãn, lao thận, suy thận, hẹp động mạch thận
  - Các bệnh của tuyến thượng thận
  - Hẹp eo động mạch chủ bẩm sinh
  - Nhiễm độc thai nghén
- Bệnh tăng HA hay THA tiên phát: là THA không rõ nguyên nhân, chiếm tới 90-95% các trường hợp THA

2. Tình hình các bệnh TM trên thế giới và ở Việt nam

2.1 Trên thế giới

2.1.1 Bệnh mạch vành. Bệnh lý tim mạch, vốn là bệnh đứng hàng đầu trong mô hình của các nước phát triển hiện ó. Ở Pháp chẳng hạn, trong số nửa triệu tử vong hàng năm, thì riêng tử vong do các bệnh tim mạch đã chiếm tới hơn 200.000, nghĩa là gần một nửa, mà 40.000 là chết đột ngột. Ở Mỹ, có 63 triệu người có một thể này hay thể khác của bệnh tim mạch, và 1,5 triệu người bị bệnh mạch vành gây ra mỗi năm 500.000 cả tử vong.

Hiện nay ở Pháp, mỗi năm vẫn còn có hơn 200.000 người chết về các bệnh của ĐMV và đó vẫn là tỉ lệ tử vong số một, cao nhất trong tất cả các nguyên nhân tử vong. Các nhà nghiên cứu cho rằng trong vòng 20 năm nữa, cho đến năm 2020, các bệnh tim nói chung và đặc biệt là các bệnh ĐMV vẫn là những bệnh đứng đầu, và vẫn là nguyên nhân của tỉ lệ tử vong cao nhất.

2.1.2 Bệnh tai biến mạch máu não (TBMMN):

Từ nhiều thập kỷ cho đến nay TBMMN vẫn là một vấn đề thời sự cấp thiết.

Đối với các nước phát triển, TBMMN là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 3 sau bệnh ung thư và tim mạch, riêng đối với Anh quốc chiếm hàng thứ tư. Tỷ lệ mắc bệnh ở các nước phát triển rất cao (794/100000 - Hoa Kỳ, 1991) trong đó 5% ở lứa tuổi 65 (Philip Kisler, 1991).

Ở Pháp năm 1974, dân số là 52.346.000, số bị TBMMN là 65.000 trường hợp, trong số này 40% - 260.000 người cần có sự chăm sóc, 10% = 6.500 người cần điều trị dài ngày. Năm 1976 tỷ lệ TBMMN ở Pháp là 60/1000 dân (theo Gauthier) và 50% thành tàn phế (Bousser và Hanin, 1985). Theo Fagnani, Gross C.R và Kolia M. (1984) ở Pháp mỗi năm có 140.000 trường hợp mới mắc. Hoa Kỳ mỗi năm chi tiêu 7 tỷ đô la cho TBMMN. Sau khi bệnh nhân xuất viện chi phí cho mỗi bệnh nhân điều trị tiếp tục tại cơ sở phục hồi chức năng là 19.285 USD (Feignensson, 1978). Tổng chi phí tính chung (nội trú và phục

hồi chức năng) của Hoa Kỳ cho TBMMN là 17 tỷ USD/năm. Ở Pháp chi phí cho TBMMN chiếm 2,5 - 3% tổng số chi phí y tế trong cả nước.

Từ năm 1975 sự ra đời của các phương pháp chẩn đoán mới như chụp cắt lớp vi tính (CT), cộng hưởng từ, chụp mạch mã hoá đi đôi với các tiến bộ trong hồi sức cấp cứu, phẫu thuật thần kinh và việc đẩy mạnh các biện phpá dự phòng đã mang lại những kết quả to lớn trong chẩn đoán và điều trị TBMMN.

Trong vòng 50 năm tỷ lệ tử vong đã giảm 30% ở các nước Âu - Mỹ. Nhật Bản mỗi năm hạ được 7% tỷ lệ tử vong, Hoa Kỳ giảm được 5% mỗi năm. Đây là một thành tựu chưa bao giờ đạt được đối với bất cứ bệnh thần kinh nào. Các tỷ lệ mới mắc và hiện mắc cũng đã hạ ở các nước Âu - Mỹ, Nhật. Tuy đã thử nghiệm nhiều phương pháp, nhưng cho đến nay chưa có phương pháp điều trị nào được coi là đặc hiệu. Vì vậy, chiến lược hiện nay coi Dự phòng là chính. Qua kinh nghiệm nhiều nước TCYTTG đã đi đến kết luận TBMMN *có khả năng dự phòng hiệu quả*

Các kết luận chung rút ra từ các công trình trong 2 thập kỷ 1970 - 1990 có thể khái quát như sau:

- Tai biến mạch máu não đã và đang giảm kể từ 50 năm trở lại đây.

- Tỷ lệ tử vong đã bắt đầu giảm từ đầu thế kỷ và giảm đều hàng năm từ 1945, có bằng chứng qua mổ tử thi 60% các ca chẩn đoán (theo điều tra tại Rochester Hoa Kỳ). Các kết quả này phù hợp với tình hình điều tra tại các nước Pháp, Anh, Bắc Âu.

Nước có tỷ lệ tử vong giảm nhanh nhất là Nhật Bản 7%/năm, rồi đến Hoa Kỳ 5%. Đến năm 1990 Hoa Kỳ đã công bố tỷ lệ tử vong giảm 27% so với thập kỷ trước và cho rằng các thầy thuốc Hoa Kỳ có quyền tự hào về thành tích này (Marray Goldstein 1990)

Những năm gần đây, các công trình nghiên cứu đã nhấn mạnh đến TBMMN ở người trẻ. Đây là đối tượng có nhiều khả năng điều trị có kết quả và là thành phần đang có nhiều cống hiến cho xã hội.

Theo Yamaguchi, tại Nhật Bản TBMMN ở người trẻ chiếm 2,7% trong số 1.350 bệnh nhân vào điều trị tại Trung tâm đột quỵ Osaka. Theo Chopra, Ấn Độ có tỷ lệ mới mắc ở người trẻ chiếm 11 đến 30% các trường hợp TBMMN

Ở Pháp tỷ lệ mới mắc ở người trẻ chiếm 10 - 30/100.000 dân, chiếm 5% toàn bộ các loại TBMMN. Dưới 45 tuổi và tai biến xuất huyết (TBXH) tương đương với trên 45 tuổi và thiếu máu cục bộ não (TMCBN) nhiều hơn 5 lần so với XH.

Tỷ lệ mới mắc, theo điều tra tại Rochester (công trình này được coi là tiêu biểu về độ tin cậy), đã giảm trong thời kỳ 1950 - 1970 và là 60%. Sự giảm tỷ lệ mắc bệnh cũng là một trong các nguyên nhân giảm tỷ lệ tử vong ở thời kỳ này. (Matsumoto. N. Stroke 1973 và 4, 9, 20).

Trong suốt 2 thập kỷ qua tình hình TBMMN là ổn định, từ năm 1980 đến nay xu hướng bị TBMMN lại có chiều hướng tăng lên nhưng tỷ lệ tử vong vẫn tiếp tục giảm. Các tác giả cho rằng sự gia tăng này là do việc áp dụng rộng rãi nhiều phương tiện chẩn đoán hiện đại, có độ chính xác cao nên phát hiện được nhiều trường hợp cũng như các thể mà chẩn đoán trước đây đã bỏ qua.

Các công trình ở Stockholm, Thuỵ Điển 1974 - 1981 cũng cho thấy tỷ lệ tử vong tiếp tục giảm nhưng tỷ lệ mới mắc không giảm. Ý kiến này đề cao việc xử lý hiệu quả giai đoạn cấp của TBMMN (Alfreson, 1986 TOHOI. H. 1976, cũng ở Thuỵ Điển)

Một số tác giả thừa nhận rằng giảm tỷ lệ tử vong và tỷ lệ mắc TBMMN là do việc khống chế huyết áp (HA) cao trong cộng đồng giữ vai trò quan trọng.

Điều khó giải thích là trong thời kỳ các nước Bắc Âu giảm tỷ lệ TBMMN thì các tỷ lệ dịch tễ học ở các nước Đông Âu lại tăng trong 2 thập kỷ qua và các tỷ lệ đó cao hơn rất nhiều lần so với các nước khác. Ở Châu Phi, quan niệm cũ cho rằng ở đó có ít người bị xơ vữa mạch (nguyên nhân chính của TBMMN) do đó tỷ lệ mắc TBMMN ít hơn các châu khác. Những công trình nghiên cứu tại Châu Phi lại thấy khác; tỷ lệ TBMMN ở các nước đang phát triển có tỷ lệ gần tương đương như ở Châu Âu. (Osuntokun 1977).

Ở các nước châu Á, (24) từ 1961 - 1970 đã có 13 công trình về dịch tễ học TBMMN, từ 1983 còn thêm các công trình mới. Từ các số liệu đã công bố thấy kết quả đưa ra rất khác nhau giữa các nước, thậm chí khác nhau giữa vùng này với vùng tiến hành ở các thời điểm gần nhau. Nhiều nước có tỷ lệ cao đến mức báo động nhưng lại có những nước có tỷ lệ rất thấp.

TCYTTG đặc biệt quan tâm đến dịch tễ học TBMMN, nhất là đối với Châu Á. Năm 1971 đã tổ chức 17 trung tâm ở 12 nước nghiên cứu toàn thế giới trong đó riêng Châu Á có 8 trung tâm ở Nhật Bản (5 trung tâm), Mông Cổ, Ấn Độ, Sri Lanka. Điều lý thú là về tuổi và giới trong tỷ lệ mới mắc qua 6 trung tâm Châu Âu có thể so sánh với các tỷ lệ của trung tâm Nhật Bản. Tại Akita, Nhật Bản, trong cộng đồng các tỷ lệ đều rất cao và TBMMN tăng theo tuổi.

Bảng 1. CÁC SỐ LIỆU DỊCH TỄ HỌC TBMMN CÔNG BỐ Ở CHÂU Á

Nước	Tỉ lệ mới mắc	Tỉ lệ hiện mắc	Tỉ lệ tử vong
Nhật Bản			196,7
- Hirosima - Nagasaki	324	3540	
- Hisayama	320	398	
- Jaboji	523	2093	
- Akita	317		
- Saka	245		
- Osaka	117		
- Fuksoka	91		
- 20 thành phố khác	340		
Trung Quốc			
- Bắc Kinh	329	1188	
- 6 thành phố khác	182	620	
Đài Loan		1642	69,7
Israel	140		95,7
Haoai		1070	
Hồng Kông			45,8
Malaysia			15,9
Singapere			35,0
Ấn Độ	13	569	
Thái Lan			11,8
- Bangkok		690	
Philippine			35,8
Ulanbator - Mông Cổ	68		
Colombô - Srilanca	29		

Qua các tài liệu công bố ta có thể rút ra một số điểm sau:

- Các nước có nền công nghiệp phát triển ở Châu Á như Nhật Bản, Đài Loan có các tỷ lệ gần tương đương với các nước phát triển Châu Âu, Châu Mỹ và tỷ lệ tử vong đã và đang giảm.

- Tuy các số liệu khác nhau (cao hoặc thấp) nhưng 2 thập kỷ qua tỷ lệ TBMMN đang tăng hàng năm. Thái Lan 1950 tỷ lệ tử vong 3,7/100.000 đến năm 1970 tăng lên 6,7/100.000 và 1983 là 11,8/100.000. Tỷ lệ mới mắc 1980 là 12,7/100.000 đến 1984 là 18,7/100.000. Các nước khác

như ở Trung Quốc tình hình TBMMN cũng đang gia tăng. Ở Đài Loan (Tapei) sự gia tăng ở mức nghiêm trọng.

2.2. Ở Việt Nam:

2.2.1 Bệnh tim mạch

Theo Niên giám Thống kê của Bộ Y tế, trong số 10 bệnh có số mắc và chết đứng đầu hàng năm cho thấy:

- Bệnh cao huyết áp có số mắc xếp hàng đứng thứ 12, năm 1993 đã lên đến hàng thứ 6 năm 1997. Số chết sắp hạng thứ 10 năm 1991, lên hạng 5 năm 1993, và vọt lên hạng thứ 3 năm 1997.
- Những tai biến mạch máu não và đột quỵ, về tử vong xếp hạng thứ 12 năm 1993, trong 4 năm đã nhẩy chín bậc, lên đến hạng 3 năm 1997.
- Bệnh nhồi máu cơ tim, những bệnh động mạch vành, về tử vong năm 1993 còn xếp ở hạng 9, sau 4 năm đã nhẩy lên năm bậc xếp ở hạng 4 năm 1997.

Theo thống kê của bệnh viện Chợ Rẫy (thành phố Hồ Chí Minh) và cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quốc tế Nhật Bản, báo cáo tại cuộc Hội thảo tháng 11 - 1997 thì số bệnh nhân tim mạch chiếm tới 19% số bệnh nhân nội khoa và tỉ lệ này có xu hướng ngày càng cao hơn. Khảo sát tại 22 bệnh viện, thấy số bệnh nhân tim mạch ngày càng tăng. Năm 1994 có 21.214 ca thì năm sau đã là 28.817 ca, và năm sau nữa (1996) đã lên đến 31.275 ca. Trong số này tỉ lệ tử vong hàng năm cao nhất là do các bệnh động mạch vành, 10% rồi đến bệnh cao huyết áp 7%. Hội nghị tim mạch các tỉnh phía Nam họp vào tháng 12-1997 nhận xét bệnh tim mạch đang gia tăng ở Việt Nam, không chỉ ở người già, mà cả ở người trẻ tuổi. Đã thấy xuất hiện những trường hợp Nhồi máu cơ tim, một số dẫn đến tử vong ở những người dưới 40 tuổi.

2.2.2 Tai biến mạch máu não

Vấn đề dịch tễ học TBMMN trong cộng đồng chỉ mới được quan tâm gần đây. Số lượng công trình nghiên cứu về vấn đề này còn rất ít.

Lê Văn Thành và cộng sự đã điều tra trên 28.000 dân ở xã Phú Mỹ, huyện Nhà Bè và phường VII quận V thành phố Hồ Chí Minh. Các kết quả ban đầu đã công bố tại Hội nghị Y - Dược thành phố Hồ Chí Minh 11/1994. Công trình này lại tiếp tục vào tháng 5, 6, 7 tại xã Đông Hoà - Châu Thành và Kiên Giang (Thị trấn Minh Lương - Châu Thành) với dân số 52.640 dân. Các tỷ lệ đều thấy cao gần giống y văn thế giới. Tỉ lệ mới mắc trung bình năm 1,52 (152/100.000), tỉ lệ mắc 4,16 (416/100.000) tỉ lệ tử vong 36,05%. Các tỉ lệ trên ở các vùng nông thôn đều cao hơn ở thành phố Hồ Chí Minh. Giải thích sự khác biệt này các tác giả cho là do ý thức của người dân về TBMMN, vấn đề quản lý, điều trị ở các vùng nông thôn kém hơn thành phố Hồ Chí Minh.

Bảng 2: TỈ LỆ TBMMN TRÊN 100.000 DÂN Ở MIỀN BẮC VÀ MIỀN TRUNG.

(Công trình nghiên cứu dịch tễ học TBMMN 1989-1994, Bộ môn Thần kinh, trường Đại học Y khoa Hà Nội. Số N điều tra 1.677.933 người)

* Tỉ lệ tử vong (Mortality)

	1993	1994	Trung bình
* Ở miền Bắc			
Nội thành Hà Nội	16,16	19,03	6,6 (1989-1994)
Ngoại thành Hà Nội	27,2		12,43 (1989-1993)
Nông thôn Thanh Oai (Hà Tây)	40	24	25 (1989-1994)
Nông thôn Thanh Hoá	43	46	44,5 (1993-1994)
* Ở miền Trung			
Nội ngoại thành Huế	43,43		19,22 (1989-1993)
Gộp chung các vùng	28,3	27,01	21,35

* Tỉ lệ hiện mắc (Prevalence)

	1993	1994	Trung bình
* Ở miền Bắc			
Nội thành Hà Nội	77,11	99,51	105 (1989-1994)
Ngoại thành Hà Nội	111		86 (1989-1993)
Nông thôn Thanh Oai (Hà Tây)	113	103	78 (1989-1994)
Nông thôn Thanh Hoá	103	112	108 (1993-1994)
Thị xã Sơn Tây	105	106	141 (1993-1994)
* Ở miền Trung	122		
Nội ngoại thành Huế	106		61,6
Gộp chung các vùng	105,69	105,13	115,92

* Nam giới bị tai biến mạch máu não nhiều hơn, tỉ lệ nữ/ nam là 1/1,48.

Nhóm dưới 50 tuổi bị TBMMN chiếm tỷ lệ thấp (9,5%) trong cộng đồng nhưng lại chiếm tỷ lệ đáng quan tâm (36%) trong bệnh viện. Tai biến thể Xuất Huyết chiếm 50% số bệnh nhân nội trú.

** Di chứng nhẹ* và vừa chiếm tỷ lệ cao 68,42% do đó đặt ra nhu cầu phục hồi chức năng rất lớn.

Di chứng vận động là chủ yếu, có ở 92,62% bệnh nhân. Tỷlệ bệnh nhân điều trị tại nhà còn cao: 51%. Riêng tại Hà Nội có tỷ lệ điều trị tại nhà 16,16% nhưng ở giai đoạn cấp chiếm tỷ lệ cao 83,4% điều trị tại các bệnh viện thành phố và trung ương (kể cả bệnh viên quân đội), điều này lý giải phần nào tỷ lệ tử vong của Hà Nội thấp.

Ở miền Nam, Trong thời gian 1994 và 1995 Bộ môn Thần kinh, Trường Đại học Y khoa TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành điều tra dịch tễ học trong cộng đồng dân ở một số vùng thuộc 3 tỉnh (TP. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Kiên Giang), cho kết qủa như sau:

+ Tỷ lệ hiện mắc chung: 415/100.000

Nhóm tuổi ≥ 46 tuổi ở TP. HCM: 1733/100.000

ở Tiền Giang: 446/100.000

ở Kiên Giang: 411/100.000

+ Tỷ lệ mới mắc chung các vùng: 161/100.000

Trong đó: TP. HCM: 114/100.000

Tiền Giang: 176/100.000

Kiên Giang: 241/100.000

Nhóm trên 46 tuổi: 697//100.000

+ Tỷ lệ tử vong (% bệnh nhân)

TP. HCM: 28

Tiền Giang: 44

Kiên Giang: 39

Yếu tố quan trọng nhất là tăng huyết áp, chiếm 55% số bệnh nhân.

3. Các yếu tố nguy cơ của các bệnh tim mạch

TỔNG QUAN VỀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA CÁC BỆNH TIM MẠCH

Các yếu tố nguy cơ của bệnh mạch vành

- yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được
  - Hút thuốc lá
  - Tăng cholesterol máu: mỡ động vật no
  - Tăng huyết áp
  - Bệnh đái đường
  - Béo phì
  - ít vận động
- yếu tố nguy cơ không thể thay đổi được
  - Tuổi
  - Giới
  - Tiền sử gia đình

Các yếu tố nguy cơ của bệnh tăng huyết áp tiên phát

- Ăn mặn
- Béo phì
- Tiền sử gia đình
- ít vận động

Các yếu tố nguy cơ của bệnh đột quị

- Tăng huyết áp
- Nguy cơ của THA
- Yếu tố nguy cơ của bệnh xơ vữa động mạch
- Giống như bệnh mạch vành

3.1 Các yếu tố nguy cơ của bệnh mạch vành

3.1.1 Tỉ lệ Cholestérol và các chất béo trong máu quá cao,

Dưới đây trình bày sự liên quan giữa tỉ lệ Cholestérol cao và nguy cơ nhồi máu cơ tim:

Tỉ lệ Cholestérol toàn phần	Nguy cơ cho tim
< 1,8 g/l	2,9%
> 2,8 g/l	12,9%

Theo công trình nghiên cứu ở Paris của J.L Richand và P. Ducimetière

(Tạp chí Tư liệu về các bệnh tim, 1977; 5; trang 431-540)

Công trình nghiên cứu ở Framingham trên một số lớn người nam giới từ 50 đến 78 tuổi, theo dõi trong hơn 4 năm, chứng minh rằng:

- Nguy cơ bị bệnh động mạch vành tăng lên song song với tỉ lệ Cholestérol LDL với một nguy cơ tối đa nếu tỉ lệ này cao hơn 2g/l và tối thiểu nếu tỉ lệ này thấp hơn 1g/l.
- Nếu tỉ lệ Cholestérol HDL cao hơn 0,85g/l thì nguy cơ hầu như không đáng kể.

Nguy cơ tối đa nếu	LDL > 2g/l
Nguy cơ tối thiểu nếu	LDL < 1,2g/l
Nguy cơ không đáng kể nếu	LDL > 0,85g/l

3.1.2 Bệnh cao huyết áp.

Cứ hai người trưởng thành thì có một người bị bệnh này. Bệnh cao huyết áp là một yếu tố đe doạ quan trọng của bệnh xơ vữa động mạch vành. Ở những người bình thường, có một số huyết áp tâm thu dưới 130, thì mỗi năm trong 1000 người chỉ có 1,2 người bị nhồi máu cơ tim (tỉ lệ 1,2 phần nghìn). Nhưng nếu huyết áp này lên đến bằng hoặc hơn 170 thì tỉ lệ sẽ là 5,2 phần nghìn, nghĩa là cao hơn 5 lần. Ở những người đã có bệnh động mạch vành, nếu huyết áp tâm thu bằng hoặc dưới 130, thì tỉ lệ xẩy ra nhồi máu chỉ có 3,3 phần nghìn. Nếu huyết áp lên đến 170 thì tỉ lệ này sẽ là 8,1 phần nghìn và nếu lên đến 190 thì tỉ lệ sẽ vọt lên đến 17,8 phần nghìn. Huyết áp tâm trương quá cao cũng tác hại không kém. Theo dõi hơn 400.000 người, các nhà nghiên cứu cũng thấy huyết áp này càng cao bao nhiêu thì mức đe doạ càng tăng lên bấy nhiêu.

3.1.3. Hút thuốc lá:

Gần đây, vào năm 1977, một công trình điều tra nghiên cứu ở Paris, do Richard J.L và cộng sự tiến hành theo dõi trong một thời gian 7 năm, 7640 người nghiện thuốc lá, hút trung bình từ 15 đến 16 điếu thuốc trong một ngày. Kết luận như sau:

- Ở người không hút thuốc, tỷ lệ xuất hiện hàng năm bệnh động mạch vành là 3,4 phần nghìn.
- Ở người hút thuốc nhưng không nuốt khói, tỷ lệ này là 4,6 phần nghìn. Còn nếu có nuốt khói thì tỷ lệ vọt lên đến 8,5 phần nghìn, nghĩa là cao hơn hai lần.

Còn sự đe doạ nhồi máu cơ tim thì cao hơn 4 lần, đe doạ chết đột ngột cao hơn 5 lần so với người không hút thuốc.

Ngày nay người ta đã biết rõ thuốc lá tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành những cục máu đông ở các động mạch vành đã bị tổn thương do các đám vữa xơ, gây ra co thắt, tắc động mạch dẫn đến nhồi máu cơ tim. Thuốc lá còn làm hại cả những người không hút thuốc nữa. Sống lâu năm trong một bầu không khí bị ô nhiễm bởi khói thuốc lá thì cũng rất nguy hiểm cho sức khoẻ của trái tim, dù rằng không hút một điếu thuốc nào.

3.1.4 Giới tính:

Phụ nữ được bảo vệ và ít bị bệnh hơn nam giới cho đến tuổi mãn kinh. Từ khoảng 10 năm nay, người ta biết một cách khẳng định là sự đe doạ của bệnh động mạch vành ở phụ nữ trước tuổi mãn kinh là thấp hơn hẳn đối với nam giới. Từ tuổi mãn kinh trở đi, thì ưu điểm này giảm dần cho đến mất hẳn. Trong lứa tuổi từ 35 đến 44 thì các bệnh ĐMV ít hơn nam giới từ 6 đến 7 lần. Trong lứa tuổi từ 45 đến 69 thì chỉ còn ít hơn có 3 lần. Sau 70 - 75 tuổi thì bị bệnh ngang với nam giới.

Như vậy sự mãn kinh có một vai trò quyết định trong việc xuất hiện những bệnh tim mạch ở phụ nữ. Trong một công trình nghiên cứu, theo dõi trong 24 năm 2.873 phụ nữ ở tỉnh Framingham, tuổi từ 29 đến 62, người ta nhận xét thấy ở những người phụ nữ đã mãn kinh - hoặc tự nhiên, hoặc sau phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng - thì bệnh động mạch vành dưới tất cả các dạng (cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim. tử vong có nguyên nhân động mạch vành) phổ biến hơn đến 2,7 lần so với những người phụ nữ cùng tuổi chưa tắt kinh. Các nhà nghiên cứu cũng nhận xét thấy sự đe doạ dường như tăng nhanh hơn ở những người mãn kinh sớm (bị cắt bỏ buồng trứng chẳng hạn).

3.1.5 Bệnh tiểu đường

Bệnh tiểu đường: tình trạng mập phì và các bệnh tim mạch là có những liên quan rất chặt chẽ với nhau. Bệnh tiểu đường gây tác hại cho nhiều cơ quan trong cơ thể: ba cái đích tấn công thường thấy nhất của nó là thận, võng mạc mắt và các thần kinh ngoại biên. Nhưng trên tất cả, nó là sự đe doạ lớn cho việc phát sinh ra các bệnh tim mạch. So sánh với người không bị bệnh tiểu đường, thì ở người có bệnh mối đe doạ này tăng cao hơn từ 2,5 đến 3,5 lần. Ở phụ nữ bị bệnh tiểu đường, mối đe doạ này tăng cao hơn đến 1,5 lần so với phụ nữ không bị bệnh.

Theo một công trình điều tra nghiên cứu ở Paris, người ta thấy, tỷ lệ của số người phát bệnh động mạch vành hàng năm như sau:

- Ở người không bị bệnh tiểu đường: 4,8 phần nghìn
- Ở người bị bệnh nhẹ: 10,3 phần nghìn
- Ở người thực sự bị tiểu đường: 16,7 phần nghìn

Tỷ lệ Cholestérol ở người bị tiểu đường là như sau:

- Cholestérol tổng quát: có tăng hơn bình thường nhưng còn nhẹ.
- Cholestérol xấu LDL: tăng rõ rệt, nhất là ở nam giới.

- Cholestérol tốt HDL: giảm rõ rệt. Nếu tỷ lệ đường huyết cao hơn 1,4 g/l (7,8mmol), thì tỷ lệ HDL sụt xuống đến dưới 0,30 g/l.

- Triglycérides và VLDL: tăng cao rõ rệt ở cả hai giới nam nữ.

Bệnh động mạch vành rất phổ biến ở bệnh nhân tiểu đường sau tuổi 50 - 60. Thường nó xuất hiện một cách im lặng, không gây những cơn đau ở ngực. Nhiều khi khám bệnh cho một người tiểu đường, thấy điện tâm đồ của người đó còn để lại dấu vết của một nhồi máu trước đây đã xuất hiện và qua ddi mà người bệnh không hề biết: Đó là những "nhồi máu không đau". Nhưng người tiểu đường thường phải trả một cái giá rất đắt: các nhồi máu rất thường xuyên xảy ra và tình trạng chết đột ngột không phải hiếm thấy.

Cho đến nay, người ta cũng chưa biết thật rõ tại sao tiểu đường lại là một nguyên nhân thuận lợi cho việc xuất hiện các bệnh tim mạch. Người ta chỉ biết rằng đường huyết tăng cao là nguyên nhân thuận lợi cho việc đông máu và tạo ra các cục máu đông.

2.1.6. Tình trạng béo phì và quá thừa cân

Để đánh giá tình trạng mập phì, người ta hay dùng nhất chỉ số "body mass index" viết tắt là BMI như sau:

$$\frac{\text{cân nặng (tính bằng kg)}}{\text{chiều cao (tính bằng mét) bình phương}}$$

Thí dụ:

Một người nam giới cao 1,75 mét, nặng 64 kg thì BMI của người đó là:

$$\frac{64}{1{,}75 \times 1{,}75} = \frac{64}{3{,}06} = 21$$

Một người phụ nữ từ 25 tuổi trở lên, cao 1,6 mét nặng 54 kg sẽ có BMI:

$$\frac{64}{1{,}6 \times 1{,}6} = \frac{54}{2{,}56} = 21$$

Nếu BMI từ 25 đến 29 thì là tình trạng béo phì cấp I, từ 30 đến 40 là cấp II và từ 40 trở lên là cấp III.

Người ta nhận xét thấy: sự đe doạ bệnh tim mạch càng cao nếu:

- Mức độ béo phì càng cao
- Nếu tình trạng béo phì càng sớm. Sau 50 tuổi thì tương đối có nhẹ hơn.
- Nếu tình trạng béo phì càng lâu. Sau 20 năm thì nặng hơn sau 10 năm.

Ở người béo phì:

- Tỷ lệ Cholestérol tổng quát và Cholestérol xấu cao hơn rõ rệt, nhất là ở người dưới 40 tuổi.

- Tỷ lệ Cholestérol tốt giảm rõ rệt.

- Tỷ lệ Triglycérides tăng rõ rệt.

Gần đây một công trình nghiên cứu của Manson J.E. và cộng sự, năm 1990 theo dõi trong 8 năm 115.886 phụ nữ Mỹ tuổi từ 30 đến 50, thấy tỷ lệ đe doạ nhồi máu cơ tim (có tử vong và không tử vong) như sau:

- Tăng 1,3 lần cho những BMI từ 21 đến 25.
- Tăng 1,8 lần cho những BMI từ 25 đến 29.
- Tăng 3,3 lần cho những BMI cao hơn 29.

3.1.7.. Các stress trong đời sống

3.1.8. Di truyền: có những "gia đình nhồi máu", có nhiều thành viên bị bệnh.

3.1.9. Tuổi càng cao càng bị đe doạ

3.2 Các yếu tố nguy cơ của TBMMN

Các yếu tố nguy cơ của TBMMN được trình bày ở bảng dưới đây :

Bảng 3: Các yếu tố nguy cơ chung cho các thể tai biến mạch máu não (TCYTTG - 1989)

	Bắc Mỹ	Âu Châu	Nam Mỹ	Nhật/ Đại Dương	Trung Quốc	Đông Nam Á Châu	Ấn Độ	Phi châu gần Sahara
Tăng HA động mạch	+	+	+	+	+	0	+	+
Tâm Thu	+	+	+	+	+	0	+	+
Tâm trương	+	+	+	+	+	0	+	+
Đái tháo đường	+	+	0	-	-	0	0	+
Các bệnh tim	+	+	+	0	+	+	0	0
TMCB thoảng qua	+	+	+	0	+	0	0	0
Béo phì	±	±	0	-	-	0	-	+
Tăng dính tiểu cầu	±	+	0	0	0	0	0	0
Rượu	±	+	0	0	+	0	0	0
Thuốc lá	+	±	0	±	±	0	-	0
Tăng lipid huyết thanh	±	0	0	±	0	0	+	0
Cholesterol	±	±	0	-	-	0	-	+
Triglycerid	±	±	0	-	0	0	-	0
Liporoteine (LDL)	±	0	0	-	±	0	0	0
Tăng acid uric máu	±	+		+				
Nhiễm khuẩn	0	0	0	0	0	0	+	0
Yếu tố di truyền; gia đình	±	+	0	0	+	±	+	0
Yếu tố khác								
Đau nửa đầu	0	+	0	0	0	0	0	0
Nhiễm lạnh	0	±	0	±	0	0	0	0
Thuốc tránh thai mạnh đo bằng oestrogene	+	+	0	0	0	0	0	0
Hoàn cảnh kinh tế	0	±	0	+	+	0	0	0
Tăng hématocrit	±	0	0	±	0	0	0	0
Giảm hématocrit	0	0	0	±	0	0	0	0
Tăng sợi tơ huyết	0	+	0	0	0	0	0	0
Protein niệu	+	0	0	+	0	0	0	0
Ăn nhiều muối	0	0	0	+	+	0	0	0

+: có; -; không ±: có thể; 0: không đủ tài liệu

4. Dự phòng các bệnh tim mạch

4.1 Các nguyên lý dự phòng các bệnh tim mạch

4.1.1 Dự phòng cấp 1

- Giảm các yếu tố nguy cơ của bệnh mạch vành
- Giảm hứt thuốc lá
- thay đổi chế dộ ăn: giảm muối, giảm mỡ béo no, giảm calo
- tăng vận động
- điều trị tăng huyết áp

4.1.2 Dự phòng cấp 2

- Chẩn đoán sớm khi mà có thể chữa khỏi được
- ví dụ: phát hiện sớm tăng huyết áp giới hạn, điều trị kịp thời, làm cho huyết áp trở về bình thường
- Phòng sự xuất hiện bệnh: thay đổi yếu tố nguy cơ hay điều tri dự phòng không cho bệnh xảy ra
- Phòng nhồi máu cơ tim, đột quị bằng thay đổi yếu tố nguy cơ và điều tri dự phòng

4.1.3 Dự phòng cấp 3

- Phòng biến chứng:
- Thay đổi yếu tố nguy cơ hay điều tri ngăn không cho biến chứng xảy ra

4.2 Cơ sở của các chiến lược dự phòng

- Mức độ và chiều hướng: tỷ lệ mới mắc và hiện mắc, DALY
- Tính sẵn có và khả thi của các biện pháp dự phòng
- Tính giá thành-hiệu qủa của các can thiệp
- Dự báo chiều hướng các bệnh TM trong tương lai
- Nhu cầu của bệnh nhân và cộng đồng
- Hiểu biết về nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ
- Sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ
- Sự hợp tác của các công ty dược

4.3 Các cách đề cập trong dự phòng các bệnh Tim mạch

- Dự phòng cá nhân
  - giáo dục SK thay đổi hành vitại cơ sở y tế, trường học, nơi làm việc, qua thông tin đại chúng, qua tiếp thị xã hội
  - sàng lọc phát hiện yếu tố nguy cơ: chỉ thành công ở những người có văn hoá cao, có điều kiện để thay đổi hành vi, bêu riếu người có nguy cơ cao, đổ trách nhiệm cho bệnh nhân
- Dự phòng cộng đồng
  - thay đổi các yếu tố kinh tế, môi trường, văn hoá, xã hội
  - thay đổi chuẩn mực/thái độ xã hội và văn hoá
  - đòi hỏi sự tham gia của cộng đồng và xã hội
  - thay đổi nguyên nhân về cấu trúc của hành vi
  - hạn chế quảng cáo thuốc lá và rượu
  - tăng giá thuốc lá và rượu
  - kiểm tra thực phẩm tại các nhà hàng và trường học

4.4 Một số biện pháp dự phòng với một số yếu tố nguy cơ cụ thể

4.4.1Giảm nồng độ cholesterol máu

Hoạt động dự phòng phải nhằm tấn công vào hai nguồn cung cấp Cholestérol: một là phải dựa vào một chế độ dinh dưỡng hợp lý nhằm hạn chế sự cung cấp Cholestérol bởi thức ăn, và hai là dùng các thuốc nhằm hãm bớt sự sản xuất Cholestérol của cơ thể. Kể cả khi ăn các thức ăn rất giầu về Cholestérol, thì trong cơ thể vẫn có một cơ chế điều chỉnh để ngăn cản sự tăng quá cao tỉ lệ Cholestérol trong máu, bằng cách thải một phần quan trọng trong mật và phân. Nhưng đối với một người ở trong diện nguy cơ, thì sự cung cấp quá nhiều Cholestérol trong thức ăn là một điều nguy hiểm, cần phải được giảm bớt đi. Trong bất cứ trường hợp nào, thì sự cung cấp Cholestérol trong 24 giờ cũng không được vượt quá 300 mg

Một chế độ dinh dưỡng lý tưởng được trình bày dưới đây

- Hạn chế đến mức tối đa các chất béo bão hoà
  - Hạn chế thịt heo, thịt bò, chọn những miếng thịt không có mỡ.
  - Nên ăn những thịt ít mỡ nhất: thịt gà, thịt thỏ, thịt bê
  - Tuyệt đối không nên ăn: óc, gan, bầu dục
  - Cũng không nên ăn: xúc xích, patê, dăm bông, thịt mỡ sấy
  - Không nên ăn bơ, mà thay bằng margarine
- Hạn chế việc cung cấp Cholestérol, chỉ dùng khoảng 300 mg/ngày.
  - Không nên ăn các thức ăn có nhiều Cholestérol như óc, gan, bầu dục, lòng đỏ trứng.
- Tăng cường ăn các dầu thực vật, thay cho mỡ động vật
- Tăng cường ăn cá. Sò, hến.. tuy có nhiều chất chống oxy hoá, nhưng cũng lại rất giầu Cholestérol, nên chỉ dùng có chừng mực.
- Tăng cường ăn ngũ cốc, ăn rau quả hàng ngày: Cà rốt, cà chua, hành, tỏi, táo và uống nhiều nước trà.

4.4.2 Phòng cho phụ nữ ở tuổi mạn kinh:

Như vậy rõ ràng hiện tượng mãn kinh là một yếu tố đe doạ đối với phụ nữ. Vì vậy phải làm gì để cải thiện tình trạng này và giảm nhẹ sự đe doạ? Ta biết rằng, trong tuổi còn sinh đẻ, buồng trứng của phụ nữ sản sinh ra hai loại hormones là: oestrogènes và progestérone. Người ta cho rằng chính oestrogènes đã có một tác dụng tích cực chống bệnh vữa xơ động mạch. Khi mãn kinh thì buồng trứng không còn sản xuất ra nó nữa. Vì vậy cần phải cung cấp cho người mãn kinh chất hormones này để bảo vệ người đó. Việc cung cấp đó được gọi là phương pháp "điều trị thay thế hormone".

Phương pháp này dùng hai loại thuốc. Đó là các thuốc oestrogènes và thuốc progestatif. Các thuốc oestrogènes có hai loại: loại được gọi là "tự nhiên" hay "bán tự nhiên" và loại được chế tạo theo phương pháp tổng hợp (thí dụ chất éthinyloestradiol). Loại tổng hợp mạnh hơn loại tự nhiên từ 200 đến 600 lần, vì vậy tuyệt đối không được sử dụng trong điều trị thay thế.

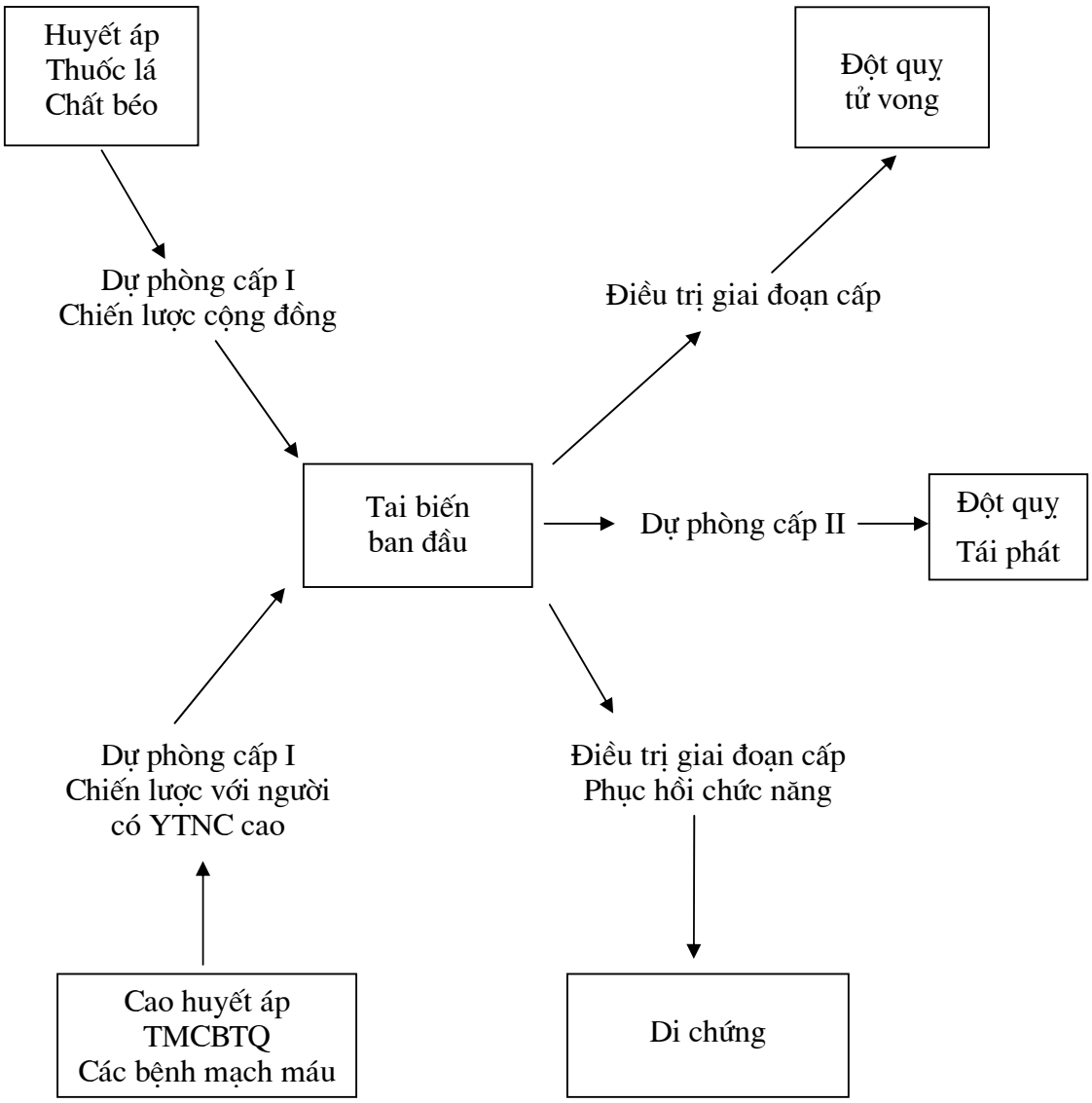
4.4.3 Dự phòng bệnh THA

- Khi chưa có bệnh THA: Luôn giữ các chế độ ăn uống, sinh hoạt, luyện tập được cân bằng, tránh ácc yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, uống rượu, căng thẳng thần kinh, ít vận động, béo bệu...Nếu trong gia đình có người thân như bố mẹ anh chị em bị bệnh THA thì phải tuân thủ chặt chẽ hơn, đặc biệt là các chế độ ăn giaem muối, và ngăn ngừa các yếu tố nguy cơ khác.
- Khi đã có bệnh THA: Phải được quản lý, theo dõi và điều trị thường xuyên tại một cơ sở y tế, đồng thời khám xét định kỳ thường xuyên để đánh giá sự tiến triển của bệnh. Bệnh nhân phải tuân theo các chế độ ăn uống, luyện tập, sinh hoạt, thuốc men hết sức chặt chẽ để giữ cho HA không bị giao động lớn. Tránh các yếu tố nguy cơ dẫn đến THA.

4.4.3 Chiến lược dự phòng TBMMN

Sơ đồ 2: **Chiến lược nâng cao sức khoẻ bằng giảm tỷ lệ mới mắc tai biến mạch máu não và tai biến mạch máu não tái phát và giảm tử vong, di chứng**

(Dennis M. Warlow C. P. Stralegy for Stroke. Br Med.J.
1991 303:636 - 38 được CHARLES WARLOW cải tiến)



Khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới 1990

4.4.3.1. Dự phòng cấp 1 (dự phòng khi chưa xảy ra tai biến)

Mục tiêu chính là phòng chống và hạn chế vữa xơ mạch, một nguyên nhân chủ yếu gây tai biến bằng các biện pháp:

- Giữ HA ở mức bình thường
- Chế độ ăn giảm các chất mỡ bão hoà, khuyên ăn các loại thịt trắng, hạn chế thịt có màu đỏ.
- Cai thuốc lá
- Dùng thuốc Aspirine: Đã thử nghiệm trên 22.000 thầy thuốc Mỹ khoẻ mạnh thấy tác dụng giảm tỷ lệ nhồi máu cơ tim và ít tác dụng với nhồi máu não. Giữa nhồi máu cơ tim và nhồi máu não có liên quan chặt chẽ vì vậy Aspirine được coi là biện pháp dự phòng cấp I quan trọng trong TBMMN.
- Cần thay đổi nếp sống phối hợp tập luyện thể dục đều.

4.4.3.2. Dự phòng cấp II (Dự phòng các tai biến mạch máu não)

Tiến hành khi xuất hiện các biểu hiện của thiếu máu cục bộ ở não hay ở võng mạc, có nghĩa là khi dự phòng cấp I đã thất bại. Ở giai đoạn này dự phòng chủ yếu nhằm:

- Phòng chống và thanh toán các yếu tố nguy cơ (huyết áp cao, đái tháo đường, các bệnh tim vv...)
- Dùng thuốc chống đông và thuốc chống kết dính tiểu cầu.

Chống các yếu tố nguy cơ:

* Chống tăng huyết áp:

- Áp dụng các biện pháp giảm trọng lượng cơ thể (chống béo phì)
- Ăn nhạt.
- Tập thể dục.
- Dùng thuốc hạ huyết áp đều đặn.
- Tránh dùng các thuốc gây tăng HA khi có bệnh khác phối hợp.

* Cai thuốc lá triệt để

Thuốc lá làm tăng Fibrinogen máu, kích thích dính tiểu cầu, tăng thể tích hồng cầu do đó làm tăng độ quánh của máu.

* Chống tăng Cholesterol máu, đặc biệt là tăng thành phần lipoprotein tỷ trọng thấp (LDL) và giảm lipoprotein tỷ trọng cao (HDL), đó là yếu tố nguy cơ của nhồi máu cơ tim và thiếu máu cục bộ não. Dự phòng bằng chế độ ăn giảm mỡ và dùng thuốc giảm Cholesterol trong máu (Clorfibral).

* Chế độ ăn muối và Ka li:

- Ăn mặn làm tăng HA. Đối với các nước nhiệt đới, chỉ nên giảm muối vừa phải do mất muối qua mồ hôi.
- Chế độ ăn ít Kali làm tăng nguy cơ TBMMN có lẽ do tăng HA. Bổ sung kali bằng ăn thêm hoa quả và rau tươi.

* Cai rượu

Rượu gây tăng huyết áp, tăng triglycerid máu, dễ gây rung nhĩ từng đợt.

* Tập thể dục có tác dụng giảm huyết áp tâm thu, tăng tỷ lệ lipoprotein tỷ trọng cao (HDL), giảm béo phì. Thể dục làm giảm tỷ lệ nhồi máu cơ tim do đó cũng làm giảm tỷ lệ TBMMN.

* Chống bệnh tăng thể tích hồng cầu:

Tăng thể tích hồng cầu gây tăng tỷ lệ TBMMN, nhất là ở phụ nữ. Cần phát hiện các nguyên nhân gây tăng thể tích hồng cầu và điều trị.

* Chống tăng tiểu cầu: Cần phải điều trị khi số lượng tiểu cầu trên 600.000/mm^3

* Chọn thuốc tránh thai có Oestrogen:

Thuốc tránh thai có nồng độ Oestrogen cao gây nguy cơ TBMMN giống như khi có thai. Chỉ nên dùng loại thuốc có nồng độ Oestrogen thấp. Dùng thuốc tránh thai khi có tăng HA và hút thuốc lá sẽ làm tăng tỷ lệ TBMMN. Ngược lại dùng Oestrogen sau khi mãn kinh lại có tác dụng giảm tỷ lệ TBMMN và bệnh mạch vành.

* Chống bệnh đái tháo đường:

Hiện nay chưa có bằng chứng chứng minh rằng giảm tỷ lệ đái tháo đường sẽ làm giảm TBMMN nhưng có nhận xét thấy bệnh nhân có đường máu cao nếu bị nhồi máu não thì bị lan toả rộng hơn so với người có đường máu ở mức bình thường.

* Bệnh hồng cầu liềm là bệnh dù ở giai đoạn tiềm tàng hay rõ rệt đều gây tỷ lệ mắc bệnh TBMMN cao.

* Phát hiện và điều trị sớm các bệnh tim:

Các bệnh tim là yếu tố nguy cơ TBMMN đứng hàng thứ hai sau vữa xơ động mạch bao gồm: loạn nhịp (đặc biệt là rung nhĩ hoặc bệnh tâm nhĩ), tổn thương van tim (hẹp van hai lá, sa van hai lá, vôi hoá van hai lá, viêm nội tam mạc nhiễm khuẩn), các tổn thương cơ tim (đặc biệt là nhồi máu mới, nhồi máu cũ có túi phồng vách), giảm động từng khúc (Akinésie segmentaire) và bệnh cơ tim.

* Các bệnh viêm mạch: phối hợp với các hiện tượng tự miễn cần phải tìm nhất là các bệnh gây ra những bất thường miễn dịch như bệnh xoắn trùng (Leptospirose), bệnh Lyme, bệnh do aspergillose, viêm màng não - mạch máu do giang mai.

Nhận xét đánh giá về chiến lược dự phòng TCYTTG cho rằng khả năng dự phòng cao hơn dựa vào tìm kiếm thuốc dự phòng mới hoặc cải tiến cách kê đơn. So sánh kết quả dự phòng gần đây với hiệu quả rất thấp của các phương pháp điều trị TMCB ở giai đoạn cấp, ta có thể coi việc điều trị dự phòng cấp I và cấp II là tiến bộ hết sức to lớn của y học.

Từ đấy nhóm nghiên cứu của Tổ Chức Y Tế Thế Giới về tai biến mạch máu não đã kết luận:

- Đã có các phương pháp dự phòng tai biến mạch máu não và có thể dùng cho cá nhân hoặc rộng rãi trong cộng đồng.

- Tiếp cận lâm sàng bổ sung nếu các xét nghiệm cho phép phân định TMCB và xuất huyết, điều này rất quan trọng đối với việc quản lý lâu dài người bệnh.

Câu hỏi thảo luận 1

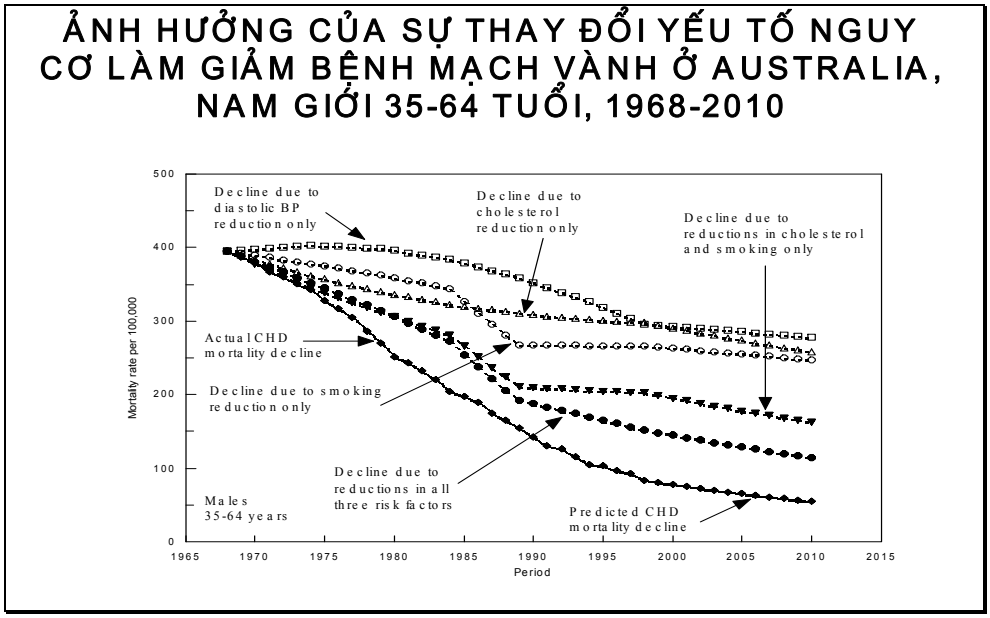
Bảng dưới đây trình bày báo cáo của Bộ y tế về những bệnh mắc và chết cao nhất toàn quốc năm 1999. Hãy phân tích vai trò của các bệnh tim mạch trong mô hình bệnh tật ở Việt nam

	Tên bệnh	Mắc /100000	Tên bệnh	Chết /100000
1.	Viêm phổi	*426.60*	Viêm phổi	*1.82*
2.	Viêm họng, viêm Amydal cấp	*291.44*	Xuất huyết não	*1.69*
3.	Viêm phế quản và viêm tiểu phế quản cấp	*250.29*	Lao hô hấp	*1.19*
4.	ỉa chảy, Viêm dạ dày, ruột non có nguồn gốc nhiễm khuẩn.	*237.32*	Thương tổn do chấn thương trong sọ	*0.99*
5.	Nạo hút thai	*161.66*	Thai chậm phát triển, duy DD,	*0.87*
6.	Cúm	*119.38*	Nhồi máu cơ tim	*0.86*
7.	Sốt rét: *Malaria*	*116.22*	Tai nạn gia thông	*0.81*
8.	Tăng huyết áp	*103.24*	Suy tim	*0.78*
9.	Tai nạn giao thông	*90.86*	Thương hàn phó thương hàn	*0.73*
10.	Lao hô hấp	*87.92*	Tự tử	*0.66*

Nguồn: Niên giám thống kê y tế 1999 (trang 67)

Câu hỏi thảo luận 2

Hãy phân tích chiều hướng và vai trò của các yếu tố nguy cơ của bệnh mạch vành được trình bày trong hình dưới đây:



Bài tập

Trong một nghiên cứu thuần tập tương lai về mối liên quan giữa Hút thuốc lá và bệnh Động mạch vành, sau 20 năm theo dõi ở một quần thể nam giới tuổi 30-49, người ta thu được kết qủa là trong số 1400 người hút thuốc lá, 400 người đã phát triển bệnh mạch vành, và trong số 3600 người không hút thuốc lá, 150 người đã phát triển bệnh động mạch vành.

Câu hỏi:

1. Hãy tính tỷ lệ mới mắc bệnh mạch vành ở ngừơi hút thuốc lá
2. Hãy tính nguy cơ tương đối và nguy cơ qui thuộc của hút thuốc lá với bệnh động mạch vành và nhận định về kết qủa đó.
3. Những sai số nào có thể đã xảy ra trong nghiên cứu này và cách khống chế.